

24 - 04- Pathologie herniaire abdominale - Pr. Narjis

(0:01 - 0:26)

Le cours qu'on va traiter aujourd'hui s'intitule la pathologie hernière abdominale, la pathologie hernière abdominale. En introduction, une hernie se définit comme étant l'issue d'un sac hernière à travers un orifice de la paroi abdominale. Cet orifice peut être naturel à travers un orifice naturel de la paroi abdominale ou acquis comme on va le voir dans la suite du cours.

(0:26 - 0:55)

Ainsi, on peut définir deux types de hernie, une hernie constitutionnelle à travers un orifice naturel ou une hernie post-opératoire provoquée par un acte opératoire chirurgical antérieur. C'est une pathologie extrêmement fréquente parce qu'elle touche un grand nombre de la population. Heureusement, elle est souvent bénigne, mais parfois, elle peut être le siège de complications qui sont extrêmement graves pour engager le pronostic vital du patient.

(0:55 - 1:05)

D'où la nécessité de bien connaître cette pathologie. Le traitement d'une hernie est toujours chirurgical. Il ne peut être conçu que par la chirurgie.

(1:07 - 1:27)

Pour le plan à suivre, après avoir vu l'introduction, nous allons faire un bref rappel anatomique de la paroi abdominale et des orifices de la paroi abdominale. Nous aborderons ensuite la classification des hernies. Nous aborderons ensuite les facteurs de risque qui peuvent entraîner l'apparition d'une hernie.

(1:28 - 1:49)

Nous verrons par la suite les éléments du diagnostic avant d'aborder les complications, puis voir le traitement et conclure. Le rappel anatomique. Pour rappel anatomique, nous allons commencer par la constitution de la paroi abdominale antérieure, en rappelant que celle-ci est formée par deux types de muscles.

(1:50 - 2:09)

Des muscles verticaux qui s'étendent de la cage thoracique et du sternum vers le pubis et qui sont constitués de deux groupes musculaires essentiellement. Les deux muscles grands droits, qui sont des muscles constants, qui descendent verticalement. Et puis un muscle qui est inconstant, qui est le muscle pyramida de l'abdomen, qui naît au niveau du pubis et qui remonte de façon inconstante.

(2:10 - 2:31)

Il peut même ne pas exister sur un certain nombre d'opérations. A côté des muscles grands droits de l'abdomen, nous avons les muscles larges de l'abdomen, qui sont en nombre de trois, essentiellement de l'extérieur vers l'intérieur. Le muscle grand oblique ou oblique externe, le muscle petit oblique ou oblique interne, et le muscle transverse de l'abdomen.

(2:31 - 3:38)

Cet ensemble musculaire se rassemble au niveau de la ligne médiane pour former ce qu'on appelle la ligne blanche abdominale antérieure. Autre coupe anatomique qui rappelle un petit peu les éléments que nous venons de citer, notamment au niveau de la partie médiane, la présence des deux muscles grands droits de l'abdomen qui descendent verticalement, et latéralement les trois groupes musculaires, le muscle oblique externe, le muscle oblique interne et le muscle transverse, notent importante sur cette diapositive, c'est la présence de cette fameuse ligne blanche qui sépare les deux groupes musculaires sur la ligne médiane. Sur cette diapositive, sur laquelle nous allons revenir également par la suite, nous allons voir les principaux types de hernie qui peuvent être décrits, notamment l'hernie épigastrique, également appelée hernie de la ligne blanche, les hernies ombilicales qui vont siéger sur l'orifice ombilical, et puis également les hernies de Spiegel qui sont beaucoup plus rares, qui vont siéger sur le bord externe du muscle grand droit.

(3:39 - 4:01)

Et puis nous avons les hernies qui sont les plus fréquentes, les hernies de la région de l'aîne, qu'on appelle les hernies inguinales et les hernies fémorales ou crurales. En anglais, ça s'appelle hernia fémorale ou fémorale hernia, mais au fait, dans la nomenclature française, on les appelle hernies crurales. Les hernies inguinales et les hernies crurales forment ce qu'on appelle les hernies de l'aîne.

(4:02 - 4:23)

Maintenant, on va passer à une partie qui est très importante qui correspond à la classification des hernies. La classification des hernies se fait essentiellement en deux grandes familles. Tout d'abord, les hernies constitutionnelles qui vont se faire à travers un orifice naturel et les hernies acquises qui vont être provoquées par la chirurgie.

(4:25 - 4:45)

Voilà, donc la diapositive suivante rappelle cette classification très importante. A la fois, les hernies constitutionnelles qui vont se faire à travers un orifice naturel de la paroi abdominale, comme ça a été décrit dans le rappel anatomique. Et puis à côté, les hernies acquises qui sont post-opératoires provoquées par une incision chirurgicale.

(4:47 - 5:01)

Concernant les hernies constitutionnelles, comme nous venons de le dire, comme nous venons de le voir, elles se font à travers un orifice naturel. Cet orifice naturel peut siéger au niveau de la région de l'aîne. Il peut siéger également au niveau de la région ombilicale.

(5:01 - 5:15)

Il peut siéger au niveau de la ligne blanche ou la région épigastrique. Et puis à côté, on a des hernies qui sont rares, notamment la hernie de Spiegel que nous allons décrire secondairement. Ce schéma rappelle encore une fois les principales hernies les plus fréquentes.

(5:15 - 5:26)

La hernie épigastrique ou hernie de la ligne blanche, c'est la même chose. La hernie ombilicale autour de l'ombilique. Puis les hernies de l'aine formées par les hernies inguinales et crurales.

(5:27 - 5:40)

Pour les hernies post-opératoires, on peut également les appeler. Le nom le plus fréquent, ce sont les éventrations post-opératoires. Les éventrations post-opératoires sont dues à un acte chirurgical abdominal antérieur.

(5:40 - 5:53)

Cet acte chirurgical antérieur peut correspondre soit à une incision de laparotomie, c'est-à-dire ouvrir l'abdomen. Laparo pour abdomen et tomie pour ouvrir l'abdomen. Soit par laparoscopie.

(5:53 - 6:05)

La laparoscopie s'appelle également cellioscopie. Donc l'éventration peut être due soit au fait d'ouvrir l'abdomen par laparotomie. Soit au fait de réaliser une laparoscopie.

(6:05 - 6:23)

Et dans les deux cas, ça s'appelle une éventration post-opératoire. Voilà, donc sur ce diapositive, nous voyons les principales incisions en chirurgie abdominale. Bien sûr, vous n'êtes pas tenu de les connaître par cœur, parce que c'est un cours adressé aux étudiants de trois années de médecine.

(6:24 - 6:34)

Mais c'est juste pour savoir les principales incisions. Notamment l'incision de la laparotomie médiane et de la laparotomie de McBurney. Donc ce sont deux incisions très importantes à connaître.

(6:34 - 6:59)

Également l'incision sous-costale droite ou appelée également incision de Kocher, qui est utilisée notamment pour faire les cholecystectomies et qui est utilisée actuellement pour la plupart de la pathologie hépatobiliaire, lorsqu'on l'aborde par voie laparotomique. Il y a aussi une incision qui est très fréquente à connaître, à titre indicatif, qui est l'incision de Fallenstiel. Pourquoi très fréquente? Parce que c'est la voie d'abord classique pour réaliser une césarienne.

(6:59 - 7:18)

Et comme on le sait, les césariennes sont très fréquentes, et donc forcément, en tant qu'étudiant en médecine, en tant qu'homme médecin, c'est bien de connaître cet abord qu'on appelle l'abord de Fallenstiel. Les autres incisions sont données à titre indicatif. Ce sont des incisions qui sont beaucoup plus rares, et ce sont des incisions qui varient en fonction des écoles.

(7:18 - 7:41)

L'école anglo-saxonne, par contre, favorise ce type d'incision, ce qu'on appelle les incisions paramédiales, qui sont beaucoup plus rares dans l'école francophone à laquelle on adhère. Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Nous savons très bien que pour pas mal de pathologies, ou pour la plupart des pathologies, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque font qu'une pathologie est plus fréquente dans une portion de la population.

(7:42 - 8:30)

La question qui se pose, c'est, pour quelle population les hernies sont-elles plus fréquentes? Les facteurs de risque sont essentiellement l'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité, qui fait que la masse musculaire va devenir moins forte, et donc va devenir plus flasque, et en devenant plus flasque, elle favorise l'apparition de la pathologie herniaire. La sédentarité, c'est par le même mécanisme, donc c'est cette capacité musculaire qui va diminuer, et cette force musculaire qui va diminuer, ce qui fait qu'on aura donc l'apparition des hernies de façon plus fréquente. Travail de charge, ça sous-entend que c'est un travail dans lequel on va soulever des charges qui sont lourdes, et en soulevant des charges qui sont lourdes au cours du travail, forcément on aura plus de hernies.

(8:31 - 8:49)

Notamment les travaux de maçonnerie, les travaux de plomberie, les sujets qui ont des travaux où ils sont obligés de soulever des masses qui sont assez lourdes. Et puis, il y a des facteurs qui sont liés à d'autres maladies. Donc la hernie peut être associée à d'autres pathologies, notamment les pathologies où on observe une hyperpression abdominale.

(8:50 - 9:08)

Lorsqu'on va tousser, on a une hyperpression abdominale. Lorsqu'on est concipé, lorsqu'on va à la selle, en étant concipé, on va pousser sur l'abdomen, et en poussant sur l'abdomen, forcément la hernie peut apparaître. La dysurie, c'est le même mécanisme, notamment dans une pathologie qui est très fréquente chez les hommes au-delà de 50 ans, donc c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate.

(9:08 - 9:38)

Lorsqu'on va avoir une dysurie, lorsqu'on va avoir une difficulté à pousser pour uriner, on va pousser, en poussant assez fort, nous pouvons observer l'apparition de hernies, notamment les hernies inguinales. Pour avoir une autre information, une petite note clinique ici, c'est que tous patients âgés de plus de 50 ans qui présentent une hernie inguinale, par exemple, vous êtes dans l'obligation de demander une échographie vésicoprostatique. Pourquoi? Pour rechercher l'hypertrophie bénigne de la prostate.

(9:39 - 9:58)

Et la cause, d'ailleurs, est l'apparition de la hernie. Si on traite la hernie sans traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate, le facteur favorisant restera en place et le patient risque de faire une récurrence de sa hernie, même s'il a été opéré de façon correcte. Maintenant, par rapport au diagnostic.

(9:59 - 10:18)

Comment va se manifester une hernie le plus souvent? Et là, nous parlons bien sûr d'une hernie qui n'est pas compliquée. Pour une hernie qui n'est pas compliquée, quels sont les éléments diagnostiques? Pour une hernie simple, dite non compliquée, trois éléments principaux sont à connaître. Tout d'abord, une hernie non compliquée n'est pas douloureuse.

(10:19 - 10:29)

Le patient ne rapporte pas de douleur au regard de la hernie. C'est une tumeur infra-ombilicale que le patient peut rapporter, qui peut même dater, mais qui n'est pas douloureuse. Donc, une notion très importante.

(10:30 - 10:40)

Deuxième notion très importante, c'est à la palpation. Vous avez déshabillé le patient, vous l'avez mis devant vous. Pour l'examen, il va se faire en position assise ou position couchée.

(10:41 - 10:56)

En faisant la palpation de l'abdomen, on va voir que la hernie se réintègre facilement dans la cavité abdominale. Il suffit de la pousser vers l'orifice herniaire pour avoir une réduction de la

hernie dans la cavité abdominale. Ça, c'est le deuxième caractèreistique.

(10:57 - 11:07)

Le troisième caractèreistique, c'est l'impulsivité à l'atout. Vous allez poser votre main sur le sac herniaire. Vous demandez au patient de tousser.

(11:08 - 11:17)

Et en toussant, vous allez sentir des vibrations. Vous allez sentir que la hernie est en train de bouger, elle est en train de pulser. Ça sous-entend que la hernie n'est pas étranglée, qu'elle n'est pas compliquée.

(11:17 - 11:23)

C'est une hernie qui est simple. Donc, trois choses très importantes pour une hernie simple. Elle est non douloureuse.

(11:23 - 11:36)

Elle est réductible dans la cavité abdominale. Et elle est impulsive à l'atout. Pour rappeler les principales formes cliniques des hernies que nous avons citées tout à l'heure.

(11:36 - 11:41)

Nous avons les hernies de l'aine. Nous avons les hernies ombilicales. Nous avons les hernies épigastriques ou de la ligne blanche.

(11:41 - 11:49)

Ça, c'est la même chose. Et puis, nous avons les hernies rares. Pour les hernies de l'aine, nous allons décrire chaque type de hernie à part dans la rubrique diagnostique.

(11:49 - 12:02)

Pour les hernies de l'aine, bien sûr, elles sont classées en deux types de hernie. Les hernies inguinales et les hernies crurales, appelées également hernie fémorale dans la nomenclature anglo-saxonne. Une hernie inguinale, c'est ça.

(12:02 - 12:15)

Cliniquement, c'est souvent cet aspect qu'on va retrouver chez le patient. C'est une tumeur fraction de la région de l'aine, de la région inguinale, qui est la zone de jonction entre le tronc et le membre inférieur. C'est la hernie la plus fréquente.

(12:15 - 12:24)

Retrouver, c'est plus de la moitié des patients qui ont une tumeur pathologique herniaire. Elle est la plus fréquente chez l'homme. Et elle se définit par une caractéristique principale.

(12:24 - 12:41)

Lorsque vous allez faire l'examen clinique, il y a une ligne qu'on appelle la ligne de Malgouen. Cette ligne de Malgouen joint l'épine du pubis à l'épine iliaque. Si la hernie, si l'horrevis herniaire siège en dessus de cette fameuse ligne de Malgouen, eh bien, on va parler de hernie inguinale.

(12:42 - 12:55)

Une hernie crurale, une hernie fémorale est la plus fréquente chez les femmes. Et là, par rapport à la hernie inguinale, c'est une hernie qui va siéger en dessous de la ligne de Malgouen. Cette distinction est très importante.

(12:55 - 13:12)

Donc, en dessus, c'est une hernie inguinale. En dessous de la ligne de Malgouen, c'est une hernie crurale ou fémorale. Pour le diagnostic différentiel, souvent le patient peut consulter pour une tumeur fraction de la région inguinale ou de la région de l'aîne sans que ça soit une hernie.

(13:12 - 13:40)

Et dans ce cas-là, il y a d'autres maladies qui sont à connaître, notamment la présence de l'hypome, qui sont fréquents dans cette région-là. Et puis, d'autres maladies, notamment un kyste du cordon spermatique chez l'homme, la présence d'une adénopathie ou d'une adénite, la présence d'une hydrosel, la présence d'une ectopithesticulaire. Donc, nous avons trois principales pathologies qui sont liées aux organes génitaux externe chez l'homme, notamment le kyste du cordon, l'hydrosel et l'ectopithesticulaire.

(13:40 - 14:08)

Et puis, nous avons deux maladies qui sont bénignes, qui sont banales, qui sont fréquentes, notamment le lipan, qui est une masse graisseuse bénigne ou une adénite, qui est une adénopathie inflammatoire qui peut être de taille variable et siégée dans la région de l'aîne. Une hernie ombilicale, c'est tout simplement une tumeur fraction au niveau de l'orifice ombilical. Sur la diapo que vous voyez, vous avez une grosse hernie ombilicale, une grosse masse au niveau de l'ombilique.

(14:09 - 14:32)

C'est une certaine population, elle est plus fréquente chez la femme, notamment en phase de grossesse. Pas mal de fois, la femme, quand elle est enceinte, elle va avoir une hyperpression abdominale de façon physiologique du fait de l'augmentation de la taille de l'utérus. Et en ayant

cette augmentation de la taille de l'utérus, nous allons avoir une hyperpression abdominale qui va entraîner la présence ou l'apparition d'une hernie ombilicale.

(14:32 - 14:43)

Et heureusement, chez la femme enceinte, souvent cette hernie, elle est bénigne. Donc la plupart des cas, après l'accouchement, la hernie va régresser et disparaître complètement. C'est une certaine population chez la femme, malheureusement, elle va persister.

(14:44 - 14:58)

Autre population à risque pour les hernies ombilicales, ce sont les patients qui sont sirotiques. Chez les patients sirotiques, également, même mécanisme. On va avoir une ascite souvent de grande abondance et la présence de cet ascite de grande abondance va faire qu'il y aura une hyperpression dans l'abdomen.

(14:58 - 15:12)

Et l'hyperpression dans l'abdomen va entraîner l'apparition d'une hernie. L'obèse aussi, nous avons vu que l'obésité est un facteur de risque majeur pour l'apparition des hernies. Et il est d'autant plus fréquent en matière de hernie ombilicale.

(15:15 - 15:35)

Les hernies de la ligne blanche ou hernie épigastrique, ce sont tout simplement des hernies qui vont apparaître en-dessus de la région ombilicale, dans la région épigastrique. Le plus souvent, elles sont les sièges du ligament rond du foie. Mais parfois, elles peuvent également être les sièges d'autres organes digestifs, d'où leur gravité et la nécessité de les opérer.

(15:36 - 15:48)

Et puis, on a une hernie qui est rare. C'est une hernie qui va siéger sur le bord externe du muscle grand droit, à ce niveau-là. Et puis, ça c'est une vue stéloscopique.

(15:49 - 15:57)

Donc, c'est la même patiente qui a été opérée et en faisant la stéloscopie, on voit qu'il y a un bel orifice. Donc, ça, c'est l'orifice herniaire. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on appelle un orifice herniaire.

(15:58 - 16:10)

Et à travers cet orifice herniaire-là, ici, vous avez de l'intestin. Cet intestin-là peut passer dans cet orifice herniaire-là, d'où la gravité des hernies. Donc, ce sont des hernies qui vont siéger sur le bord externe du muscle grand droit de l'abdomen.

(16:10 - 16:26)

Et ce sont des hernies, à mon avis, qui sont extrêmement rares. Maintenant, pour les hernies qui sont acquises, pour la pathologie herniaire acquise, comme nous l'avons vu, ce sont des éventrations post-opératoires. Dans la nomenclature anglo-saxonne, on les appelle également hernie incisionnelle.

(16:27 - 16:35)

Incisionnelle herniaire. Et puis, en français, ce sont éventrations post-opératoires. Il y a même certaines publications récentes qui parlent de hernie incisionnelle.

(16:35 - 16:51)

C'est la même chose. Comme on l'a vu, soit c'est une laparotomie, soit c'est une laparoscopie qui va entraîner l'apparition d'une éventration post-opératoire. Sur ce diapositif, nous voyons une cicatrice de laparotomie.

(16:52 - 17:03)

Et en regard de la cicatrice de laparotomie médiane, nous avons une tumefaction. Cette tumefaction-là correspond à une hernie incisionnelle ou à une éventration post-opératoire. C'est la même chose.

(17:04 - 17:19)

Comme on l'a vu précédemment, la hernie peut siéger sur n'importe quelle incision, qu'elle soit médiane, qu'elle soit sous-costale, qu'elle soit de McMurray ou de Feinstein, ou même de laparoscopie. La taille est variable et l'évolution également est variable. Et le siège est variable aussi.

(17:21 - 17:39)

Alors maintenant, pourquoi faut-il traiter ces hernies ? Qu'est-ce qui fait leur gravité ? Leur gravité réside dans le fait qu'on peut avoir des complications qui sont liées à ces hernies. Et donc forcément, il faut les opérer, il faut les traiter. Quelles sont ces complications ? Ces complications sont au nombre de trois.

(17:39 - 17:53)

La plus grave et pour laquelle une prise en charge en urgence doit être préconisée, c'est l'étranglement herniaire. C'est la complication la plus fréquente. A côté de ça, nous avons deux autres complications.

(17:53 - 18:16)

L'engouement herniaire et le trouble cutané en regard du sac herniaire. L'étranglement herniaire correspond à quoi ? L'étranglement herniaire, comme on l'a vu, c'est une extrême urgence. Extrême urgence, pourquoi ? Parce que vous allez avoir un passage d'un contenu herniaire qui peut être de l'intestin, comme on peut le voir sur ce schéma ou sur cette image per opératoire.

(18:17 - 18:34)

Et le risque, c'est quoi ? C'est d'arriver à ça. Ça, c'est quoi ? C'est une nécrose intestinale qui est due au fait que l'ence intestinale qui est sortie a été strangulée par l'aérine. Et le fait qu'il y ait cette strangulation, la complication majeure qui peut survenir, c'est une nécrose intestinale.

(18:34 - 18:53)

Et par exemple, chez ce patient-là, qu'on voit sur la diapositive, nous avons été obligés de couper cette ence intestinale et puis de faire une anastomose entre les deux bois intestinaux. Pourquoi ? Parce que cette ence digestive était morte. Et si le patient avait encore traîné un petit peu, s'il n'avait pas consulté, le risque serait d'arriver qu'il y ait une perforation de l'ence intestinale.

(18:53 - 19:17)

En ayant une perforation de l'ence intestinale, le patient serait rentré en choc, c'est-à-dire sur une péritonite, et le pronostic vital serait engagé. Donc vous voyez très bien que l'étranglement herniaire est une complication qui est extrêmement fréquente. Maintenant, comment peut-on diagnostiquer un étranglement herniaire ? Là, il faut revenir aux caractéristiques que nous avons citées tout à l'heure par rapport à une hernie qui est simple, qui n'est pas étranglée.

(19:17 - 19:36)

Nous avons dit qu'une hernie non étranglée, une hernie qui est simple, non compliquée, n'est pas douloureuse, elle est réductible, elle est impulsive à la toux. Quand une hernie s'étrangle, quand elle devient étranglée, c'est tout à fait l'inverse. L'hernie va devenir douloureuse, elle va devenir non réductible, elle va devenir non impulsive à la toux.

(19:36 - 19:53)

Retenez ces trois caractéristiques, elles sont très importantes. Donc, hernie étranglée, c'est une hernie qui est douloureuse, c'est une hernie qui n'est pas réductible dans l'abdomen, et c'est une hernie qui n'est plus impulsive à la toux lorsqu'on va palper l'abdomen. Donc, l'étranglement est une notion très importante à connaître.

(19:53 - 20:23)

À côté de l'étranglement, nous avons une complication qui est moins évidente à reconnaître, notamment par un médecin généraliste, mais que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle

l'engouement herniaire. L'engouement herniaire, ce n'est pas l'étranglement herniaire, c'est une hernie qu'on ne va pas arriver à réduire dans l'abdomen sans qu'elle soit étranglée. Et cela est dû au fait que l'hernie a tellement traîné, elle est tellement chronique qu'elle a commencé à créer des adhérences entre le sac et le contenu.

(20:23 - 20:49)

Le fait qu'il y ait des adhérences au sein du sac herniaire va faire qu'on ne va pas arriver à réintroduire le contenu herniaire dans la cavité abdominale. Maintenant, comment le distinguer d'un étranglement herniaire ? C'est une douleur qui va régresser, ce sont des épisodes douloureux à répétition, ce n'est pas une douleur qui est intense et qui va persister. Elle est impulsive à la toux.

(20:49 - 21:08)

Lorsque vous allez poser votre main sur la hernie, elle va bouger, elle est impulsive à la toux. C'est ce qu'on appelle l'engouement herniaire et c'est l'apanage des volumineuses hernies. Lorsque vous avez une hernie qui est très volumineuse, qui a traîné, qui est chronique, les adhérences vont se former et vont provoquer ce qu'on appelle l'engouement.

(21:09 - 21:23)

C'est une hernie qui est le plus souvent à l'extérieur, qu'on n'arrive pas à réduire, mais qui n'est pas étranglée. Maintenant, le traitement. Le traitement est très important parce que toute hernie diagnostiquée doit être traitée.

(21:25 - 21:33)

Traitée comment ? Traitée chirurgicalement. Tous les autres traitements ne sont pas adéquats pour une hernie. Tous les autres traitements ne vont pas guérir une hernie.

(21:34 - 21:54)

Toute hernie qui a été diagnostiquée doit être adressée au médecin chirurgien pour procéder à un traitement chirurgical pour traiter la hernie. Maintenant, le principe de la chirurgie est très simple, il suffit de refermer l'orifice. Nous avons un orifice qui fait qu'il y a une communication entre un sac et l'extérieur.

(21:54 - 22:06)

Le principe c'est de refermer l'orifice. Et pour refermer l'orifice, nous avons deux procédés thérapeutiques. Soit qu'on va utiliser l'aponévrose pour refermer l'orifice hernière.

(22:07 - 22:25)

Soit qu'on va utiliser un matériel qui est externe, ce qu'on appelle une prothèse pour refermer l'orifice hernière. Pour le traitement aponévrotique, le principe comme je viens de le dire, il suffit de suturer les aponévroses. Nous avons un trou, nous avons un orifice entre les aponévroses.

(22:25 - 22:48)

On va prendre du fil qui n'est pas réservable, c'est-à-dire un fil qui va rester dans notre corps humain, qui ne va pas fondre, qui ne va pas disparaître. Avec lequel nous allons rapprocher les berges de l'aponévrose pour refermer l'orifice hernière. Plusieurs procédés ont été décrits, il ne faut pas les connaître par cœur, ce sont des procédés qui sont chirurgicaux, qui sont assez techniques.

(22:48 - 23:07)

Notamment le rapprochement en bord à bord, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les deux berges d'un orifice hernière, deux berges aponévrotiques. Le procédé en palto, c'est-à-dire faire passer une berge sur l'autre de façon chirurgicale. Mais comme j'ai dit, ce sont des procédés techniques, vous n'êtes pas censé connaître ces techniques chirurgicales.

(23:08 - 23:34)

L'inconvénient, le principal inconvénient du traitement aponévrotique, c'est que les récurrences sont très fréquentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va rapprocher par des sutures les berges aponévrotiques, les deux berges seront sous tension. Et lorsqu'on a des berges qui sont sous tension, il suffit que le patient tousse, il suffit que le patient ait une constipation, il suffit que le patient ait un facteur de risque qui va faire qu'on aura une hyperpression abdominale pour que les sutures lâchent.

(23:34 - 23:47)

Et si les sutures aponévrotiques lâchent, là on va avoir ce qu'on appelle une récurrence de la hernie. Et donc il faudra réopérer le patient une nouvelle fois. Donc ça c'est un inconvénient majeur pour le traitement aponévrotique.

(23:48 - 24:04)

Et donc le taux est variable en fonction des séries, mais globalement vous voyez qu'il peut arriver même jusqu'à 40%, ce qui est un taux qui est très important. Donc un patient sur deux va avoir une récurrence, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi le traitement aponévrotique est limité aux petites hernies.

(24:05 - 24:17)

Parce que nous avons une toute petite hernie, donc ça se prête assez bien au traitement

aponévrotique. Et puis également lorsqu'on a des patients qu'on opère en urgence. Parce que comme on va le voir pour le traitement prothétique, on ne peut pas mettre une prothèse chez n'importe qui.

(24:17 - 24:39)

Et donc notamment dans le contexte de l'urgence, lorsqu'on va avoir des sutures digestives, si on met une plaque ou une prothèse, c'est la même chose, on va avoir un risque sceptique, un risque infectieux. Et donc c'est pour ça que le plus souvent, lorsqu'on a une hernie qui est tranglée en urgence, on va procéder à un traitement aponévrotique. Là ce sont quelques petites images pour illustrer ce que c'est qu'un traitement aponévrotique.

(24:40 - 24:49)

Ici on a une hernie inguinale à ce niveau là. Vous voyez bien qu'on va prendre un fil et on va suturer des berges. Parce que la hernie sortait par là au début.

(24:50 - 24:59)

Et donc forcément on va commencer à faire des sutures, à rapprocher des berges pour fermer l'orifice hernière. Donc l'aspect définitif c'est ça. Ici nous avons un orifice hernière.

(24:59 - 25:16)

Et donc là on a mis des sutures au-dessus pour fermer l'orifice à travers lequel la hernie ressortait. Maintenant pour le traitement prothétique. Le principe c'est quoi? C'est de mettre en place une prothèse, ou également appelée plaque par certains chirurgiens, pour renforcer la paroi.

(25:16 - 25:27)

La prothèse on peut la mettre où on veut, le siège est extrêmement variable. Les types de prothèses là aussi sont très variables, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Donc on peut avoir des prothèses qui sont résorbables et qui peuvent fendre.

(25:28 - 25:40)

On peut avoir des prothèses qui vont rester sur place. Vous n'êtes pas censé connaître pour votre troisième année de médecine les détails techniques de ces procédés. Juste à titre d'information, on peut mettre la plaque de deux façons.

(25:40 - 25:52)

Soit par cellioscopie ou par laparoscopie. Soit par laparotomie, en ouvrant l'abdomen et en refermant sur la plaque. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des prothèses? Parce que c'est le

traitement de référence maintenant pour pas mal de pathologies hernières.

(25:52 - 26:07)

Tout simplement parce que le taux de récurrence est extrêmement faible lorsqu'on va utiliser une prothèse. Si on compare par rapport à un traitement aponeurotique, on a moins de 5% de récurrence. Moins de 5% comparé aux 10 à 40% du traitement aponeurotique, il n'y a pas photo.

(26:07 - 26:20)

Donc à chaque fois qu'on peut mettre une prothèse pour traiter une pathologie hernière, on la met pour que le patient n'ait pas une récurrence. Ça c'est très important. Maintenant le traitement prothétique n'est pas idéal.

(26:20 - 26:37)

Il a également ses complications et ses complications les plus fréquentes malheureusement ce sont les infections. Pourquoi? Parce que la prothèse est un matériel qui est exogène. Lorsqu'on met un matériel qui est exogène dans le corps humain, le risque majeur, c'est le risque septique, c'est qu'on peut avoir des infections sur la prothèse.

(26:37 - 26:58)

Et donc c'est une complication qu'il faut connaître. Ici vous avez différentes photos prises en pair opératoire qui montrent un petit peu ce que c'est qu'un traitement prothétique pour une hernie. Ici par exemple vous avez ce qu'on appelle une prothèse biface, c'est une prothèse à double face qu'on va placer par voie celluloscopique.

(26:58 - 27:18)

Donc c'est la même plaque qu'on a mise ici par voie celluloscopique et on l'a fixée par ce qu'on appelle des tacks. Ce sont des agrafeuses, ici vous avez une agrafeuse, ici une autre agrafeuse. Et la plaque a été mise dans le corps pour pouvoir un petit peu sur la part abdominale pour empêcher la sortie des viscères à travers un orifice qui était initialement placé à ce niveau là.

(27:19 - 27:35)

Ici sur cette autre image vous avez un traitement celluloscopique d'une hernie inguinale. Là c'est une prothèse qui n'est pas résorbable et sur laquelle on est en train de refermer avec du péritoine pour protéger l'intestin de cette plaque là. Ici vous avez un traitement classique, un traitement par l'aparotomie.

(27:35 - 27:56)

Un traitement par l'aparotomie, on a ouvert l'abdomen, vous avez ici le muscle grand droit de l'abdomen avec la pornevrose antérieure à ce niveau là. Et là vous avez la plaque, cette plaque là, on l'a placée en pré-péritoniale. Donc on a ouvert, on a refermé le péritoine en dessous, on a mis la plaque dessus et puis on va refermer au dessus de la plaque par le muscle grand droit de l'abdomen à ce niveau là.

(27:58 - 28:13)

En conclusion, que peut-on dire? On peut dire que la pathologie hernière est très fréquente. Et donc en tant que futur médecin de famille ou futur médecin généraliste, vous devez connaître ce que c'est qu'une pathologie hernière. Pourquoi? Parce que le diagnostic est très facile.

(28:14 - 28:28)

Donc si vous avez remarqué dans le cours, nous n'avons quasiment pas parlé des examens complémentaires. Pourquoi? Parce que souvent on n'a pas besoin d'examens complémentaires pour confirmer une hernie. Donc les examens complémentaires sont limités à certaines situations qui sont extrêmement rares.

(28:28 - 28:47)

Donc le diagnostic est le plus souvent clinique. Les complications, elles sont graves, dont la nécessité d'un traitement chirurgical, le plus souvent qui est le seul traitement, je le dis, je le répète, c'est le seul traitement qui peut guérir d'une hernie. Si vous diagnostiquez une hernie, il faut adresser le malade au chirurgien pour traiter la hernie de façon chirurgicale.

(28:47 - 29:03)

Il y a des avancées thérapeutiques majeures, comme vous l'avez vu, par rapport au nombre de résidus et des complications. C'est la mise en place de prothèses et l'abord laparoscopique. Lorsque vous mettez une prothèse, vous avez moins de 5% de complications, ce qui est extrêmement bon pour le patient.

(29:04 - 29:05)

Bon courage et bonne continuation.